EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92624
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-12 10:18:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROSA ELVIRA SEPULVEDA VERA			RUN	: 3.821.169-2
F.Nac	: 20-03-1933	Edad	: 91 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LLAHUIMAVIDA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 54994045		
Fecha Ingreso	: 2024-09-03	Fecha Egreso	: 2024-09-12 10:18:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV ISQUEMICO ACA DERECHO + ESTENOSIS INTRACRANEALES MÚLTIPLES (AMBAS ACA, ACM)
2. ITU TRATADA
3. HTA
4. DM2 NO IR
5.DERMATITIS DE PAÑAL
6. DÉFICIT B12 SUPLEMENTADO
7. HIPOACUSIA
8. POSTRADA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. L20-L30-DERMATITIS Y ECZEMA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

mRS 3, CON ANTECEDENTES DESCRITOS, CONSULTA EL 02.09.24 TRAS AMANECER CON MAYOR SOMNOLENCIA Y DIFICULTAD PARA MOVILIZAR HEMICUERPO IZQUIERDO, EN URGENCIAS PAS 160, ECG EN RITMO SINUSAL, SIN CONFLICTO VENTILATORIO, AL EXAMEN CON SOMNOLENCIA, DIFICULTAD PARA COMPRENDER ORDENES, HEMIPLEJIA BC IZQUIERDA, TC CEREBRO CON HIPODENSIDAD EN TERRITORIO ACA DERECHA Y ANGIOTAC CON MULTIPLES FOCOS DE ESTENOSIS SIGNIFICATIVA EN AMBAS ACA Y ACM. INGRESA PARA MANEJO DE ACV.
EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE, POR PEAK FEBRIL SE DG ITU CON OC Y UC COMPATIBLE, SE AJUSTA PROGRESIVAMENTE ANTI-HTA CON BUENA RESPUESTA, DEBIDO A SD APATICO SECUNDARIO A INFARTO ACTUAL, SE INDICA MODAFINILO PARA OPTIMIZAR TERAPIA DE REHABILITACIÓN CON BUEN RESPUESTA. INDICO MANTENER REHABILITACION CON HODOM POR BUEN PRONÓSTICO DEGLUTORIO.

_____

Al examen físico:
- bien hidratada y perfundida, lesiones costrosas difusas glúteo izquierdo, disminución dermatitis zona pañal, RR2T sin soplos, MP+ SRA, abdomen blando no doloroso, edema- TVP-

Ex neurológico:
- vigil espontánea, comprende órdenes simples, emite escaso lenguaje hipofónico disártrico
- isocoria reactiva, CV conservado, oculomotilidad N, PFC izquierda leve
- M0 hipotónico BC izquierdo, plantar extensor izquierdo
- respuesta simétrica al dolor

PLAN DE MANEJO:

FORTALECER REHABILITACIÓN KINÉSICA Y FONOAUDIOLÓGICA

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO EN CAMA 30°, PREVENCIÓN UPP, CONTENCIÓN MECÁNICA SOS
2. REGIMEN CERO POR BOCA/ ALIMENTACION INDICADA POR NUTRICIÓN Y FONOAUDIOLOGÍA
3. ASPIRINA 100 MG SNG DIA
4. CLOPIDOGREL 75 MG SNG DIA
5. ATORVASTATINA 80 MG SNG DIA
6. PARACETAMOL 1 GR SNG SOS
7. FAMOTIDINA 40 MG SNG DIA
8. SERTRALINA 50 MG 1/2 X DIA SNG
9. MODAFINILO 200 MG 1/2 COMPRIMIDO VO DIA AM (7 am)
10. LOSARTAN 50 MG SNG C/12 HRS
11. FUROSEMIDA 40 MG SNG C/12 HRS
12. CARVEDILOL 6,25 MG C/12 HRS
13. PASTA LASSAR C/8 HRS EN ZONA PAÑAL
14. CLOTRIMAZOL CREMA C/8 HRS AREA PAÑAL
15. CONTROL AL ALTA DE HODOM POR NEUROLOGIA (HACER INTERCONSULTA AL ALTA)
16. IC APS PROGRAMA POSTRADOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

10.09.24: CREA 0,4, PCR 12, BUN 27, UREMIA 57, NA+ 138, K+ 4, CL- 101HTO 43,9, LEUCOCITOS 8900, PLAQUETAS 110.000, INR 1,2
07.09.24: pcr 10, cREA 0,4, nA+ 141, k+ 3,8, cL- 105, UREMIA 64, HTO 43,8%, LEUCOCITOS 10700, PLAQUETAS 123.000
TC Y ANGIOTC CUELLO Y CEREBRO
ECG
TSH 5.2, T4L 0.8, B12 168
COL TOTAL 112, LDL 40, HDL 44, TG 139
H. GLICOSILADA 5,9%

Control en: 20 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO